

Malang, 27 April 2026

Nomor : 233.54/DPM/I-PB/DIR/IV/2026
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Surat Pemberitahuan Survei Akreditasi

Kepada Yth.

1. Direktur RS Prima Husada Malang
2. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
3. Direktur RS Dharma Husada Probolinggo

Di Tempat

Dengan hormat,

Terkait dengan jadwal Survei Simulasi Akreditasi di Rumah Sakit Prima Husada Malang dan Sukorejo, dengan ini kami menginfokan jadwal Survei Simulasi sebagai berikut :

NO.	INSTANSI	DARING		SURVEYOR	LURING			SURVEYOR
		HARI / TANGGAL	PUKUL		HARI / TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	
1.	RS Prima Husada Sukorejo	Selasa, 28 April 2026	08.00 WIB – Selesai	1. dr. Ari Putriani, Sp.PK 2. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP	Rabu – Kamis / 29 – 30 April 2026	08.00 WIB – Selesai	RS Prima Husada Sukorejo	1. dr. Lovi Krissadi Endari, M.ARS., CHt 2. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
2.	RS Prima Husada Malang	Selasa, 5 Mei 2026	08.00 WIB – Selesai	1. dr. Ari Putriani, Sp.PK 2. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP	Rabu – Kamis / 6 – 7 Mei 2026	08.00 WIB – Selesai	RS Prima Husada Malang	1. dr. Lovi Krissadi Endari, M.ARS., CHt 2. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Seluruh materi dari masing-masing Penanggung Jawab Bab **wajib** sudah terunggah melalui tautan *Google Drive*:
<https://drive.google.com/drive/folders/16vqmpAOhQh7RvNwddBGtnI597PqJtl2z> sebelum pelaksanaan kegiatan survei.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

RUNDOWN SURVEI SIMULASI AKREDITASI RS PRIMA HUSADA

KONFIRMASI REGULASI DAN DOKUMEN (H-5)			
HARI	JAM (WIB)	ACARA/AGENDA	
		SURVEIOR MANAJEMEN	SURVEIOR ASUHAN
HARI PERTAMA SURVEI (DARING)	07.30	Link Zoom dibuka Persiapan	
	07.50 – 08.00	Safety Briefing (bila dalam satu ruangan ≥ 20 orang)	
	08.00 – 08.20	PEMBUKAAN - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Doa - Sambutan Direktur RS - Sambutan dan pembukaan survei oleh Ketua Tim Survei serta pembacaan kode etik surveior KARS	
	08.20 – 09.00	Presentasi Direktur tentang : - Profil Rumah Sakit, - Presentasi Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, yang mencakup : - metode yang digunakan dalam peningkatan mutu RS - proses pemilihan prioritas perbaikan RS (menggunakan skoring) pelayanan risiko tinggi dan penyakit yang dipilih; - penetapan IMP RS dan evaluasi hasil capaian; - pengukuran terhadap outcome mutu (dampak perbaikan primer dan sekunder dari IMP RS); - evaluasi hasil capaian INM; - pengukuran IMP Unit (IGD, Rawat inap, Kamar Operasi, Farmasi, Laboratorium), termasuk mutu yang terkait dengan evaluasi kinerja staf klinis - upaya keselamatan RS - pemantauan terhadap IKP - manajemen risiko - penetapan profil risiko RS dan upaya mitigasinya	
	09.00 – 09.15	Konfirmasi oleh Tim Surveior terhadap presentasi Direktur	
	09.15 – 10.00	Wawancara Pimpinan, Pemilik/Representasi Pemilik dan Jajaran Direksi RS tentang upaya peningkatan mutu dan keselamatan RS, termasuk budaya keselamatan	
	10.00 – 10.15	ISTIRAHAT	
		KONFIRMASI DOKUMEN (Konfirmasi terhadap dokumen yang telah ditelaah melalui SIDOKAR jika dokumen belum lengkap atau diperlukan penjelasan)	
	10.15 – 10.45	Konfirmasi dokumen TKRS dan PMKP 1	Konfirmasi dokumen AKP dan PP



	10.45 - 11.45	Konfirmasi dokumen KPS dan MFK	Konfirmasi dokumen PAP
	11.45 - 12.15	Konfirmasi dokumen PPI	Konfirmasi dokumen PKPO
	12.15 – 13.15	ISHOMA	
	13.15 – 13.45	Konfirmasi dokumen MRMK, Prognas dan PPK	Konfirmasi dokumen SKP dan KE
	13.45 – 14.30	Telusur dokumen peningkatan mutu, upaya keselamatan dan manajemen risiko di unit :	Konfirmasi dokumen HPK dan PAB
	14.30 – 15.00	• pemilihan IMP unit • proses pengumpulan data mutu prioritas unit • validasi data mutu prioritas unit • analisa data mutu prioritas unit • upaya perbaikan mutu prioritas unit • pelaporan mutu unit • pelaporan insiden keselamatan pasien • risk register unit • upaya mitigasi risiko di unit • pelaporan manajemen risiko unit	Telusur rekam medis untuk proses asuhan : • pengkajian awal dan pengkajian ulang (medis dan keperawatan), dan bukti integrasi bukti asuhan terintegrasi untuk menyusun rencana asuhan (termasuk bukti keterlibatan MPP) • penyusunan perencanaan pemulangan pasien (discharge planning) • dokumentasi proses transfer • dokumentasi proses rujukan • dokumentasi komunikasi antar staf klinis • telusur informed consent pasien operasi • telusur kasus MAM • rekam medis proses bedah : SSC, asesmen pra bedah, asesmen pra anestesi dan pra induksi, pemantauan durante anestesi, pemantauan masa pemulihan dan penilaian kesiapan pasien meninggalkan ruang pemulihan, rencana asuhan pasca bedah
	15.00 – 16.30	Telusur manajemen SDM : • penetapan kebutuhan ketenagaan unit • perencanaan SDM • proses rekrutment • proses seleksi	Telusur farmasi : • telaah rekonsiliasi obat • pengkajian resep • verifikasi 5 benar dan double check

		• orientasi • penilaian kinerja karyawan baru • proses kredensial • OPPE Dokter • penilaian kinerja perawat, bidan dan nakes lain terkait mutu unit proses perencanaan pendidikan dan pelatihan	• PTO dan pemantauan ESO Telusur edukasi: • identifikasi kebutuhan edukasi • materi edukasi kolaboratif • proses pemberian edukasi • edukasi rujukan
	16.30 – 16.45	Koordinasi dengan PIC Manajemen	Koordinasi dengan PIC Asuhan
	16.45 – 19.30	ISTIRAHAT	
	19.30 – 20.30	Koordinasi Surveior	
TELUSUR IMPLEMENTASI			
HARI	JAM (WIB)	ACARA/AGENDA	
		SURVEIOR MANAJEMEN	SURVEIOR ASUHAN
HARI KEDUA SURVEI (LURING)		Telusur menggunakan metode observasi, simulasi dan wawancara (termasuk telusur manajemen fasilitas dan PPI)	Telusur menggunakan metode observasi, simulasi dan wawancara (termasuk telusur KE)
	08.00 – 09.00	Rawat Jalan	Rawat inap medikal bedah
	09.00 – 10.00	IGD (termasuk Ponsek)	
	10.00 – 10.15	ISTIRAHAT	
	10.15 – 11.15	Unit pelayanan (Rawat inap, Unit intensif, PICU - NICU, dll)	Kamar Operasi
	11.15 – 12.00		Admisi / pendaftaran
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 14.00	Prognas	Farmasi dan pencampuran obat
	14.00 – 14.30	Kamar Operasi	Gudang farmasi
	14.30 - 15.30	TPS B3 - TPS Domestik - IPAL - Kamar Jenazah	Rawat Jalan
	15.30 – 16.00	Koordinasi dengan PIC	Koordinasi dengan PIC Asuhan
		Manajemen	
		16.00 – 19.30	ISTIRAHAT
	19.30 – 20.30	Koordinasi Surveior	
TELUSUR IMPLEMENTASI			
HARI	JAM (WIB)	ACARA/AGENDA	
		SURVEIOR MANAJEMEN	SURVEIOR ASUHAN
HARI KETIGA SURVEI (LURING)	08.00 – 08.45	SANTIAJI	
		Telusur menggunakan metode observasi, simulasi dan wawancara (termasuk telusur manajemen fasilitas dan PPI)	Telusur menggunakan metode observasi, simulasi dan wawancara (termasuk telusur KE)
	08.45 – 09.45	Gizi dan dapur pengolahan	Rawat intensif (HCU, ICU, Perina, PICU, NICU)
	09.45 – 10.30	Linen Laundry	

	10.30 – 11.30	CSSD	IGD
	11.30 – 12.00	Telusur mutu dan manajemen risiko - wawancara dengan Kepala Unit, PIC data dan Komite Mutu	Pelayanan pengaduan
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 14.00	Telusur PPI - wawancara dengan Komite PPI dan IPCN	Laboratorium - UTD dan Radiologi
	14.00– 15.00	Simulasi Code Red & Evakuasi	Simulasi Code Blue
	14. 30- 15.00	Penyusunan Laporan Penutup	
	15.00 – 15.30	PERTEMUAN PENUTUP	
	15.30– 19.30	ISTIRAHAT	
	19.30 – 20.30	Koordinasi Surveior untuk penyusunan laporan survei	

Hormat kami,
Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE